

Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG)

1. Introducción y relevancia clínica

El **Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG)** se caracteriza por una **preocupación excesiva, persistente y difícil de controlar** sobre múltiples aspectos de la vida cotidiana (salud, trabajo, familia, dinero, etc.), acompañada de síntomas físicos de **hiperactivación autonómica**.

A diferencia de otras formas de ansiedad, el TAG **no está restringido a situaciones o estímulos específicos**, sino que es **crónico y difuso**, afectando la calidad de vida y el funcionamiento social o laboral del paciente.

Su **prevalencia** se estima entre **4–7% de la población general**, con predominio en mujeres, y suele iniciar en la **adolescencia o adultez temprana**.

En Chile, el TAG es un motivo frecuente de consulta en APS, donde muchas veces se presenta **con síntomas somáticos** (cefalea, insomnio, palpitaciones) que conducen a estudios innecesarios si no se identifica el componente ansioso.

- En el **EUNACOM**, este tema aparece frecuentemente en:
 - Casos clínicos con “pacientes ansiosos crónicos” o “somatizadores”.
 - Preguntas sobre tratamiento de primera línea (ISRS + TCC).
 - Diagnóstico diferencial con pánico, hipertiroidismo o depresión.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El TAG es un trastorno **multifactorial**, que resulta de la interacción entre factores **neurobiológicos, psicológicos y ambientales**.

2.1. Bases neurobiológicas

- **Hiperactividad del sistema límbico**, especialmente la **amígdala**, que procesa el miedo y la amenaza.
- **Déficit en la regulación cortical prefrontal**, que impide controlar la respuesta emocional.

- **Disminución de neurotransmisores inhibitorios (GABA)** y alteración de serotonina y noradrenalina.
- **Hiperactividad del eje hipotálamo–hipófisis–adrenal (HHA)**, con liberación sostenida de cortisol.

2.2. Factores psicológicos

- **Tendencia al perfeccionismo** y preocupación excesiva por el futuro.
- Aprendizaje de **conductas ansiosas en la infancia** (modelado parental).
- Dificultad para tolerar la incertidumbre o el control limitado.

2.3. Factores de riesgo

- Antecedente familiar de ansiedad o depresión.
 - Personalidad ansiosa o inhibida.
 - Estrés crónico o traumas tempranos.
 - Abuso de sustancias estimulantes (caféina, nicotina).
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Criterios diagnósticos (DSM-5 / CIE-10)

A. Ansiedad y preocupación excesivas (anticipación aprensiva) sobre diversas actividades o eventos, presentes la mayor parte del tiempo durante **≥6 meses**.

B. El individuo tiene dificultad para controlar la preocupación.

C. La ansiedad se asocia con **≥3 de los siguientes síntomas** (solo 1 en niños):

1. Inquietud o sensación de estar “al límite”.
2. Fatigabilidad fácil.
3. Dificultad para concentrarse o mente en blanco.
4. Irritabilidad.

5. Tensión muscular.
6. Trastornos del sueño (insomnio, sueño no reparador).

D. La ansiedad causa **malestar clínico significativo o deterioro funcional**.

E. No se debe a sustancias o condiciones médicas.

3.2. Presentación clínica típica

Dominio	Manifestaciones
Psíquicas	Preocupación constante, pensamientos catastróficos, sensación de pérdida de control.
Somáticas	Palpitaciones, sudoración, temblores, tensión muscular, molestias gastrointestinales.
Cognitivas	Dificultad para concentrarse, indecisión, pensamientos rumiativos.
Conductuales	Evitación de responsabilidades, búsqueda excesiva de seguridad o chequeos médicos.

☐ En APS, el TAG se presenta frecuentemente como “**síndrome somático funcional**”, con exámenes normales.

3.3. Curso clínico

- Curso **crónico y fluctuante**, con exacerbaciones ante estrés.
 - Frecuente comorbilidad con **depresión mayor** (hasta 60%).
 - En muchos pacientes, **el TAG precede o acompaña** a otros trastornos ansiosos.
-

3.4. Diagnóstico diferencial

Entidad	Características distintivas
Trastorno de pánico	Crisis breves e intensas con miedo a morir o perder control.
Fobia específica o social	Ansiedad ante estímulos concretos o situaciones sociales.
TOC	Pensamientos intrusivos (obsesiones) y rituales (compulsiones).
Hipertiroidismo o feocromocitoma	Taquicardia, temblor, pérdida de peso, exámenes alterados.
Depresión	Ánimo bajo predominante; la preocupación es más por culpa o desesperanza.

☐ Diferenciar TAG de **pánico** es clásico en EUNACOM: el TAG es “constante y difuso”; el pánico es “paroxístico y breve”.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Aunque el diagnóstico es **clínico**, deben descartarse causas médicas y evaluar comorbilidades.

Examen	Utilidad
TSH, T4L	Descartar hipertiroidismo.
Glucemia, electrolitos	Evaluar causas metabólicas.

ECG

Taquicardia, efectos de ansiolíticos.

Cuestionarios validados: GAD-7,
HADS

Cuantificar severidad (GAD-7 ≥ 10 = ansiedad moderada).

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile 2023)

El manejo del TAG debe ser **integral**, combinando **farmacoterapia, psicoterapia y abordaje psicosocial**.

5.1. Psicoterapia (primera línea)

Terapia cognitivo-conductual (TCC):

- Identificación de pensamientos distorsionados (“catastrofismo”, “intolerancia a la incertidumbre”).
- Técnicas de relajación y respiración.
- Exposición progresiva a situaciones temidas.
- Reestructuración cognitiva y entrenamiento en afrontamiento.

Evidencia: la TCC tiene eficacia comparable a los ISRS, con menor recaída a largo plazo.

Ideal combinar ambas estrategias.

5.2. Farmacoterapia

Primera línea: ISRS (inhibidores selectivos de recaptura de serotonina)

- **Sertralina:** iniciar con 25–50 mg/día, titular hasta 100–200 mg.
- **Escitalopram:** 10 mg/día (máx. 20 mg).
- **Paroxetina o fluoxetina** como alternativas.

Segunda línea: IRSNa (serotonina-noradrenalina)

- **Venlafaxina:** útil si falla ISRS o hay comorbilidad depresiva.
- **Duloxetina:** alternativa con efecto en dolor somático.

Benzodiacepinas (uso breve y controlado)

- **Clonazepam o lorazepam** solo en crisis intensas o al inicio del tratamiento ISRS.
- Suspender progresivamente (riesgo de dependencia).

Otros:

- **Buspirona:** ansiolítico no benzodiacepínico, útil en casos leves.
 - **Pregabalina:** alternativa en ansiedad resistente.
-

5.3. Medidas no farmacológicas

- Ejercicio aeróbico regular.
 - Higiene del sueño (rutina, evitar pantallas).
 - Reducción de cafeína y alcohol.
 - Mindfulness o meditación guiada.
-

5.4. Duración del tratamiento

- Continuar ISRS **mínimo 6–12 meses** tras remisión completa.
 - Suspender gradualmente para evitar síndrome de discontinuación.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones

- **Depresión mayor** (hasta 60% de los casos).
- **Abuso de alcohol o fármacos ansiolíticos.**
- **Deterioro funcional laboral y familiar.**
- **Somatización crónica y consultas médicas reiteradas.**

Pronóstico

- **Bueno** con tratamiento combinado (ISRS + TCC).
- **Recaídas** si se suspende precozmente el tratamiento.
- **Mal pronóstico:** inicio temprano, comorbilidad depresiva o abuso de benzodiacepinas.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. TAG = ansiedad **difusa, persistente y no situacional** por ≥ 6 meses.
2. Los **ISRS** (sertralina, escitalopram) son el tratamiento de elección.
3. **TCC** es igual de efectiva y debe combinarse con fármacos.
4. Las **benzodiacepinas solo se usan transitoriamente.**
5. Descartar **causas médicas** (TSH, hipoglucemia, consumo de estimulantes).
6. Evaluar comorbilidad depresiva y abuso de sustancias.
7. **Educación y seguimiento** son esenciales para prevenir cronificación.



Errores comunes

- Tratar solo con benzodiacepinas prolongadamente.
 - No diferenciar TAG de **pánico** (TAG = crónico; pánico = episódico).
 - No realizar búsqueda de causas orgánicas.
 - Suspender ISRS antes de 6 meses.
 - No ofrecer psicoterapia estructurada.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **TAG** es un trastorno crónico caracterizado por **preocupación excesiva y síntomas somáticos** durante ≥ 6 meses.
2. Es **altamente prevalente** y motivo frecuente de consulta en APS.
3. El tratamiento de elección es **ISRS + Terapia Cognitivo-Conductual**.
4. Las **benzodiacepinas** son de **uso breve** para alivio sintomático inicial.
5. Evaluar siempre **comorbilidades** (depresión, abuso de sustancias).
6. El **diagnóstico es clínico**, descartando causas médicas.
7. La **educación y el seguimiento prolongado** mejoran el pronóstico y reducen recaídas.